BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

QUY TRÌNH KỸ THUẬT DA LIỄU

Bản cập nhật theo đề cương QĐ 3023/QĐ-BYT — trình thẩm định, chưa ban hành

Ngày rà soát: 13/10/2026. Bộ gồm 25 quy trình. Mã DL-01 đến DL-25 là mã đề xuất.

Trách nhiệm	Xác nhận
Biên soạn	……
Thẩm định chuyên môn Da liễu	……
Kiểm tra thuốc và sản phẩm	……
Kiểm tra thiết bị / kiểm soát nhiễm khuẩn	……
Phê duyệt, quyết định và hiệu lực	……

Nguyên tắc áp dụng

QĐ 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 được dùng cho đề cương và thể thức. Nguồn thao tác chuyên môn là hướng dẫn chuyên ngành, đúng nhãn thuốc và hướng dẫn sử dụng (IFU) của thiết bị/sản phẩm thực tế. Không dùng QĐ3023 làm căn cứ cho liều thuốc hoặc cài đặt laser.

Bản nguồn đã được rà soát và giữ nguyên riêng. Bộ này bổ sung quy trình bệnh hói bị thiếu trong danh mục, tách khỏi quy trình IPL; sửa các điểm không nhất quán về nồng độ triamcinolone, hoạt hóa PRP, đơn vị IPL và bảo vệ mắt LED. Các tên quy trình phối hợp sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc được giữ để truy vết tài liệu năm 2017; không đồng nghĩa đã xác nhận mọi sản phẩm hiện có được phép dùng.

Chỉ triển khai kỹ thuật thuộc phạm vi hoạt động và danh mục được phép của bệnh viện, do người được phân công đủ năng lực thực hiện. Bác sĩ xác lập chỉ định và thao tác xâm lấn theo phạm vi hành nghề; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi theo phân công. Không mở rộng vai trò điều dưỡng chỉ vì có tài liệu này.

Chưa được cung cấp model, IFU, danh mục sản phẩm và thuốc thực tế. Các thông số cần thiết được ghi trong phiếu xác nhận cuối bộ; phải điền, kiểm tra và phê duyệt trước sử dụng. Đây là điều kiện vận hành cần xác nhận, không phải y lệnh mẫu để áp dụng ngay.

Nguồn đề cương: https://bvdksadec.vn/Uploads/files/1_%20DE%20CUONG-2023_%20QD%203023%20HUONG%20DAN%20QUY%20TRINH%20KHAM%20BENH,%20CHUA%20BENH.pdf

Danh mục quy trình

DL-01. Chăm sóc da và lấy nhân mụn trứng cá

DL-02. Chụp và phân tích da bằng máy phân tích da

DL-03. Giảm lông bằng IPL

DL-04. Hỗ trợ điều trị trứng cá bằng IPL

DL-05. Điều trị bệnh hói bằng lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

DL-06. Điều trị rám má bằng lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

DL-07. Điều trị bệnh lý sắc tố bằng laser Nd:YAG Q-switched trên hệ thống Harmony

DL-08. Điều trị tàn nhang bằng lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

DL-09. Điều trị giãn lỗ chân lông bằng lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

DL-10. Điều trị lão hóa da bằng lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

DL-11. Hỗ trợ điều trị trứng cá bằng đèn LED

DL-12. Điều trị rụng tóc bằng lăn kim và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

DL-13. Điều trị sẹo lồi bằng tiêm triamcinolone trong tổn thương

DL-14. Điều trị da bằng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP)

DL-15. Điều trị sùi mào gà bằng laser CO_2

DL-16. Điều trị rụng tóc từng vùng bằng tiêm triamcinolone trong tổn thương

DL-17. Điều trị sẹo lõm bằng tách đáy sẹo

DL-18. Phi kim bằng bút điều trị trẻ hóa da

DL-19. Sinh thiết da

DL-20. Tách huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP)

DL-21. Tiêm vi điểm (mesotherapy)

DL-22. Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng laser CO_2

DL-23. Điều trị u mềm treo bằng laser CO_2

DL-24. Điều trị dày sừng da dầu bằng laser CO_2

DL-25. Điều trị sẩn cục bằng laser CO_2

DL-01. CHĂM SÓC DA VÀ LẤY NHÂN MỤN TRỨNG CÁ

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Loại bỏ nhân mụn được chọn và hỗ trợ phác đồ trứng cá; không thay thế điều trị nguyên nhân.

2. CHỈ ĐỊNH

Nhân đầu đen hoặc đầu trắng được bác sĩ đánh giá có thể lấy an toàn.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nhiễm trùng lan rộng, tổn thương hoại tử tại vùng thao tác; không lấy nhân trên nốt, nang hoặc mụn viêm sâu.

4. THẬN TRỌNG

Da nhạy cảm, đang dùng retinoid, rối loạn đông máu; tránh gây tổn thương chỉ để lấy hết nhân.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Đánh giá và đánh dấu nhân mụn phù hợp; đối chiếu phác đồ đang dùng.

6.2. Bước 2

Làm sạch nhẹ nhàng; sát khuẩn vùng can thiệp bằng sản phẩm phù hợp, chờ khô.

6.3. Bước 3

Dùng dụng cụ vô khuẩn; mở nhân khi có chỉ định bằng dụng cụ dùng một lần; ép nhẹ đúng hướng, dừng khi đau nhiều hoặc không lấy được.

6.4. Bước 4

Thấm sạch dịch, kiểm tra chảy máu và tổn thương; không nặn mụn bọc hay chà xát toàn vùng.

6.5. Bước 5

Chăm sóc phục hồi theo y lệnh. LED chỉ thực hiện khi có chỉ định riêng theo quy trình LED.

6.6. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-

BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Không cạy mụn; làm sạch dịu, chống nắng phù hợp. Báo khi đau tăng, đỏ lan, mủ hoặc sốt. Không bắt buộc xông nóng hay đắp mặt nạ lên da vừa tổn thương.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

American Academy of Dermatology. Hướng dẫn điều trị trứng cá 2024; bằng chứng cho một số kỹ thuật hỗ trợ còn hạn chế. https://www.aad.org/member/clinical-quality/guidelines/acne/

CDC. Safe injection practices. https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-02. CHỤP VÀ PHÂN TÍCH DA BẰNG MÁY PHÂN TÍCH DA

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Ghi hình chuẩn hóa và hỗ trợ đánh giá diễn biến; kết quả máy không tự xác lập chẩn đoán.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh cần lưu hình hoặc hỗ trợ đánh giá theo chỉ định bác sĩ.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không sử dụng chế độ ánh sáng chống chỉ định theo hướng dẫn máy; người bệnh không đồng ý ghi hình.

4. THẬN TRỌNG

Nhạy cảm ánh sáng; chỉ số tuổi da hoặc sắc tố là kết quả thuật toán, không thay thế khám hay sinh thiết.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Không có thuốc bắt buộc cho ghi hình đơn thuần; không tự dùng thuốc gây tê hoặc chất cảm quang.

5.3. Vật tư

Vật tư vệ sinh tiếp xúc và bảo vệ theo hướng dẫn máy; không yêu cầu vô khuẩn cho ghi hình không xâm lấn.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Xác nhận mục đích, đồng ý ghi hình; làm sạch da và tháo vật che vùng khảo sát.

6.2. Bước 2

Kiểm tra máy, chế độ ánh sáng, vệ sinh bề mặt tiếp xúc; bảo vệ mắt theo hướng dẫn.

6.3. Bước 3

Đặt tư thế, khoảng cách và ánh sáng chuẩn; chụp đủ góc, kiểm tra ảnh rõ và đúng người.

6.4. Bước 4

Bác sĩ đọc kết quả cùng khám lâm sàng; chụp lại khi sai tư thế hoặc chất lượng kém.

6.5. Bước 5

Lưu ảnh có ngày, vùng và chế độ; hạn chế quyền truy cập, không dùng quảng cáo khi chưa có đồng ý riêng.

6.6. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Dừng khi khó chịu ở mắt, chóng mặt hoặc đau; đánh giá nguyên nhân. Không ghi nhận “không có tai biến” một cách tuyệt đối.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-03. GIẢM LÔNG BẰNG IPL

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

IPL là ánh sáng xung cường độ cao; dải bước sóng và bộ lọc tùy thiết bị, đơn vị là nm. Không bảo đảm triệt lông vĩnh viễn hoặc chữa khỏi trứng cá.

2. CHỈ ĐỊNH

Lông tăng trưởng tại vùng được bác sĩ chỉ định sau đánh giá nguyên nhân và loại da.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nhiễm trùng hoặc tổn thương chưa chẩn đoán tại vùng điều trị; không đáp ứng điều kiện an toàn của hướng dẫn máy.

4. THẬN TRỌNG

Da rám nắng, thuốc gây nhạy sáng, isotretinoin và thời gian sử dụng cần bác sĩ đối chiếu hướng dẫn chuyên môn và máy; không dùng một khoảng ngừng thuốc cho mọi kỹ thuật.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Khám, xác định loại da, vùng, thuốc và mục tiêu; chụp ảnh khi được đồng ý.

6.2. Bước 2

Kiểm tra máy, bộ lọc, đầu phát, làm mát; chọn thông số có y lệnh và hướng dẫn sử dụng đối chiếu.

6.3. Bước 3

Cho người bệnh và nhân viên đeo bảo vệ mắt đúng phổ phát; làm sạch da, chuẩn bị vùng lông theo hướng dẫn máy.

6.4. Bước 4

Thử vùng nhỏ khi được chỉ định; đánh giá đáp ứng trước điều trị toàn vùng.

6.5. Bước 5

Phát xung có kiểm soát, di chuyển theo bản đồ vùng và mức chồng lấn được phép; theo dõi đau, đỏ, phỏng và dừng khi bất thường.

6.6. Bước 6

Làm mát phù hợp, kiểm tra da; ghi bộ lọc, năng lượng, độ rộng xung, số xung và đáp ứng.

6.7. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Chống nắng, tránh kích thích da; không bóc bóng nước. Tái khám khi phỏng, đau tăng hoặc đổi màu kéo dài. Lịch lặp lại do bác sĩ quyết định theo đáp ứng.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

American Academy of Dermatology. Hướng dẫn điều trị trứng cá 2024; bằng chứng cho một số kỹ thuật hỗ trợ còn hạn chế. https://www.aad.org/member/clinical-quality/guidelines/acne/

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-04. HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TRỨNG CÁ BẰNG IPL

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

IPL là ánh sáng xung cường độ cao; dải bước sóng và bộ lọc tùy thiết bị, đơn vị là nm. Không bảo đảm triệt lông vĩnh viễn hoặc chữa khỏi trứng cá.

2. CHỈ ĐỊNH

Trứng cá được bác sĩ lựa chọn điều trị bổ trợ; giải thích mức độ bằng chứng và các lựa chọn khác.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nhiễm trùng hoặc tổn thương chưa chẩn đoán tại vùng điều trị; không đáp ứng điều kiện an toàn của hướng dẫn máy.

4. THẬN TRỌNG

Da rám nắng, thuốc gây nhạy sáng, isotretinoin và thời gian sử dụng cần bác sĩ đối chiếu hướng dẫn chuyên môn và máy; không dùng một khoảng ngừng thuốc cho mọi kỹ thuật.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Khám, xác định loại da, vùng, thuốc và mục tiêu; chụp ảnh khi được đồng ý.

6.2. Bước 2

Kiểm tra máy, bộ lọc, đầu phát, làm mát; chọn thông số có y lệnh và hướng dẫn sử dụng đối chiếu.

6.3. Bước 3

Cho người bệnh và nhân viên đeo bảo vệ mắt đúng phổ phát; làm sạch da, chuẩn bị vùng lông theo hướng dẫn máy.

6.4. Bước 4

Thử vùng nhỏ khi được chỉ định; đánh giá đáp ứng trước điều trị toàn vùng.

6.5. Bước 5

Phát xung có kiểm soát, di chuyển theo bản đồ vùng và mức chồng lấn được phép; theo dõi đau, đỏ, phỏng và dừng khi bất thường.

6.6. Bước 6

Làm mát phù hợp, kiểm tra da; ghi bộ lọc, năng lượng, độ rộng xung, số xung và đáp ứng.

6.7. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Chống nắng, tránh kích thích da; không bóc bóng nước. Tái khám khi phỏng, đau tăng hoặc đổi màu kéo dài. Lịch lặp lại do bác sĩ quyết định theo đáp ứng.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

American Academy of Dermatology. Hướng dẫn điều trị trứng cá 2024; bằng chứng cho một số kỹ thuật hỗ trợ còn hạn chế. https://www.aad.org/member/clinical-quality/guidelines/acne/

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-05. ĐIỀU TRỊ BỆNH HÓI BẰNG LĂN KIM VÀ SẢN PHẨM TỪ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Tạo vi tổn thương có kiểm soát. Các tên "tế bào gốc", "exosome" không đồng nghĩa; không được mặc định là sản phẩm an toàn dùng trên da bị phá vỡ hàng rào. Hiệu quả phụ thuộc chỉ định và bằng chứng của kỹ thuật/sản phẩm.

2. CHỈ ĐỊNH

Bệnh hói được bác sĩ chẩn đoán, lựa chọn kỹ thuật hỗ trợ trong phạm vi được phép.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nhiễm trùng, mụn viêm hoạt động hoặc tổn thương nghi ác tính tại vùng thao tác; không dùng sản phẩm chưa xác minh tính hợp pháp, vô khuẩn và đường sử dụng.

4. THẬN TRỌNG

Nguy cơ tăng sắc tố, sẹo, rối loạn đông máu, cơ địa sẹo lồi, bệnh nền và thuốc đang dùng. Phân biệt hói kiểu androgen với rụng tóc từng vùng, nấm và rụng tóc sẹo; không cam kết tái tạo nang tóc.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Bác sĩ xác lập chẩn đoán, loại trừ bệnh không phù hợp và ghi mục tiêu, vùng điều trị.

6.2. Bước 2

Xác nhận thiết bị, kim vô khuẩn dùng một lần; nếu phối hợp sản phẩm phải ghi tên, thành phần, số lô, hạn dùng, đường dùng và tài liệu cho phép.

6.3. Bước 3

Làm sạch; gây tê khi có y lệnh, tính tổng liều; loại bỏ thuốc tê, sát khuẩn phù hợp và chờ khô.

6.4. Bước 4

Cài độ sâu, tốc độ hoặc lực thao tác theo vùng và hướng dẫn thiết bị đã được bác sĩ xác nhận; không áp dụng một độ sâu cho mọi vị trí.

6.5. Bước 5

Thao tác từng vùng có kiểm soát, theo dõi đau và tổn thương; không cố tạo chảy máu làm điểm kết thúc.

6.6. Bước 6

Chỉ dùng sản phẩm phối hợp khi đã đủ điều kiện ở bước kiểm tra; nếu chưa đủ, dừng phần phối hợp và báo bác sĩ, không tự thay sản phẩm.

6.7. Bước 7

Làm sạch nhẹ, chăm sóc thích hợp, đánh giá trước rời phòng; bỏ kim vào hộp vật sắc nhọn.

6.8. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Hướng dẫn vệ sinh, chống nắng khi da dung nạp; tránh trang điểm và chất kích ứng đến khi hàng rào da hồi phục. Báo đau tăng, mủ, đỏ lan, sốt hoặc tăng sắc tố. Không ấn định mọi người được trang điểm sau 12 giờ.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

FDA. Microneedling devices: nguy cơ và giới hạn sử dụng phối hợp sản phẩm. Đây là nguồn cảnh báo an toàn của Hoa Kỳ, không thay thế quy định lưu hành tại Việt Nam. https://www.fda.gov/medical-devices/aesthetic-cosmetic-devices/microneedling-devices

CDC. Safe injection practices. https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-06. ĐIỀU TRỊ RÁM MÁ BẰNG LĂN KIM VÀ SẢN PHẨM TỪ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Tạo vi tổn thương có kiểm soát. Các tên “tế bào gốc”, “exosome” không đồng nghĩa; không được mặc định là sản phẩm an toàn dùng trên da bị phá vỡ hàng rào. Hiệu quả phụ thuộc chỉ định và bằng chứng của kỹ thuật/sản phẩm.

2. CHỈ ĐỊNH

Rám má được bác sĩ lựa chọn can thiệp sau tư vấn điều trị chuẩn và chống nắng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nhiễm trùng, mụn viêm hoạt động hoặc tổn thương nghi ác tính tại vùng thao tác; không dùng sản phẩm chưa xác minh tính hợp pháp, vô khuẩn và đường sử dụng.

4. THẬN TRỌNG

Nguy cơ tăng sắc tố, sẹo, rối loạn đông máu, cơ địa sẹo lồi, bệnh nền và thuốc đang dùng. Rám má có thể tăng sắc tố sau viêm hoặc tái phát; giải thích bằng chứng hạn chế của sản phẩm phối hợp.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Bác sĩ xác lập chẩn đoán, loại trừ bệnh không phù hợp và ghi mục tiêu, vùng điều trị.

6.2. Bước 2

Xác nhận thiết bị, kim vô khuẩn dùng một lần; nếu phối hợp sản phẩm phải ghi tên, thành phần, số lô, hạn dùng, đường dùng và tài liệu cho phép.

6.3. Bước 3

Làm sạch; gây tê khi có y lệnh, tính tổng liều; loại bỏ thuốc tê, sát khuẩn phù hợp và chờ khô.

6.4. Bước 4

Cài độ sâu, tốc độ hoặc lực thao tác theo vùng và hướng dẫn thiết bị đã được bác sĩ xác nhận; không áp dụng một độ sâu cho mọi vị trí.

6.5. Bước 5

Thao tác từng vùng có kiểm soát, theo dõi đau và tổn thương; không cố tạo chảy máu làm điểm kết thúc.

6.6. Bước 6

Chỉ dùng sản phẩm phối hợp khi đã đủ điều kiện ở bước kiểm tra; nếu chưa đủ, dừng phần phối hợp và báo bác sĩ, không tự thay sản phẩm.

6.7. Bước 7

Làm sạch nhẹ, chăm sóc thích hợp, đánh giá trước rời phòng; bỏ kim vào hộp vật sắc nhọn.

6.8. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Hướng dẫn vệ sinh, chống nắng khi da dung nạp; tránh trang điểm và chất kích ứng đến khi hàng rào da hồi phục. Báo đau tăng, mủ, đỏ lan, sốt hoặc tăng sắc tố. Không ấn định mọi người được trang điểm sau 12 giờ.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

FDA. Microneedling devices: nguy cơ và giới hạn sử dụng phối hợp sản phẩm. Đây là nguồn cảnh báo an toàn của Hoa Kỳ, không thay thế quy định lưu hành tại Việt Nam. https://www.fda.gov/medical-devices/aesthetic-cosmetic-devices/microneedling-devices

CDC. Safe injection practices. https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-07. ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ SẮC TỐ BẰNG LASER ND:YAG Q-SWITCHED TRÊN HỆ THỐNG HARMONY

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Laser Q-switched điều trị tổn thương sắc tố được lựa chọn; không đồng nhất với laser xung dài hoặc picosecond.

2. CHỈ ĐỊNH

Tổn thương sắc tố có chẩn đoán và phù hợp bước sóng/đầu máy thực tế.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tổn thương nghi ác tính chưa được chẩn đoán; không đủ điều kiện bảo vệ mắt hay thông số xác nhận.

4. THẬN TRỌNG

Rám má, da sẫm màu, rám nắng, thuốc nhạy sáng: nguy cơ tăng/giảm sắc tố và tái phát; cân nhắc test vùng nhỏ.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Khám và xác định tổn thương; sinh thiết trước phá hủy nếu chưa loại trừ ác tính.

6.2. Bước 2

Xác nhận đúng model, đầu Q-switched và bước sóng đang có; kiểm tra máy, khóa an toàn và thông số chỉ định.

6.3. Bước 3

Bảo vệ mắt đúng bước sóng và mật độ quang học theo hướng dẫn; xử lý vùng gần mắt bởi người đủ năng lực.

6.4. Bước 4

Làm sạch da, chuẩn bị theo hướng dẫn; thử vùng khi được chỉ định và đánh giá.

6.5. Bước 5

Phát xung từng vùng, kiểm soát điểm kết thúc theo loại tổn thương; dừng khi đau bất thường, phỏng hoặc phản ứng vượt dự kiến.

6.6. Bước 6

Làm mát/chăm sóc, ghi bước sóng, năng lượng, kích thước điểm, tần số, số lượt và đáp ứng.

6.7. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Chống nắng và theo dõi phỏng, rối loạn sắc tố, sẹo; lịch điều trị tiếp theo dựa đáp ứng, không áp dụng chung một khoảng cách buổi.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

Alma. Harmony XL Pro, mô tả công nghệ. Tài liệu giới thiệu không thay thế hướng dẫn sử dụng của đúng máy và đầu điều trị. https://almalasers.co.in/product/harmony-xl-pro/

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-08. ĐIỀU TRỊ TÀN NHANG BẰNG LĂN KIM VÀ SẢN PHẨM TỪ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Tạo vi tổn thương có kiểm soát. Các tên "tế bào gốc", "exosome" không đồng nghĩa; không được mặc định là sản phẩm an toàn dùng trên da bị phá vỡ hàng rào. Hiệu quả phụ thuộc chỉ định và bằng chứng của kỹ thuật/sản phẩm.

2. CHỈ ĐỊNH

Tàn nhang có chẩn đoán được bác sĩ lựa chọn kỹ thuật hỗ trợ.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nhiễm trùng, mụn viêm hoạt động hoặc tổn thương nghi ác tính tại vùng thao tác; không dùng sản phẩm chưa xác minh tính hợp pháp, vô khuẩn và đường sử dụng.

4. THẬN TRỌNG

Nguy cơ tăng sắc tố, sẹo, rối loạn đông máu, cơ địa sẹo lồi, bệnh nền và thuốc đang dùng. Không phá hủy tổn thương sắc tố nghi ngờ; giải thích khả năng tái phát.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Bác sĩ xác lập chẩn đoán, loại trừ bệnh không phù hợp và ghi mục tiêu, vùng điều trị.

6.2. Bước 2

Xác nhận thiết bị, kim vô khuẩn dùng một lần; nếu phối hợp sản phẩm phải ghi tên, thành phần, số lô, hạn dùng, đường dùng và tài liệu cho phép.

6.3. Bước 3

Làm sạch; gây tê khi có y lệnh, tính tổng liều; loại bỏ thuốc tê, sát khuẩn phù hợp và chờ khô.

6.4. Bước 4

Cài độ sâu, tốc độ hoặc lực thao tác theo vùng và hướng dẫn thiết bị đã được bác sĩ xác nhận; không áp dụng một độ sâu cho mọi vị trí.

6.5. Bước 5

Thao tác từng vùng có kiểm soát, theo dõi đau và tổn thương; không cố tạo chảy máu làm điểm kết thúc.

6.6. Bước 6

Chỉ dùng sản phẩm phối hợp khi đã đủ điều kiện ở bước kiểm tra; nếu chưa đủ, dừng phần phối hợp và báo bác sĩ, không tự thay sản phẩm.

6.7. Bước 7

Làm sạch nhẹ, chăm sóc thích hợp, đánh giá trước rời phòng; bỏ kim vào hộp vật sắc nhọn.

6.8. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Hướng dẫn vệ sinh, chống nắng khi da dung nạp; tránh trang điểm và chất kích ứng đến khi hàng rào da hồi phục. Báo đau tăng, mủ, đỏ lan, sốt hoặc tăng sắc tố. Không ấn định mọi người được trang điểm sau 12 giờ.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

FDA. Microneedling devices: nguy cơ và giới hạn sử dụng phối hợp sản phẩm. Đây là nguồn cảnh báo an toàn của Hoa Kỳ, không thay thế quy định lưu hành tại Việt Nam. https://www.fda.gov/medical-devices/aesthetic-cosmetic-devices/microneedling-devices

CDC. Safe injection practices. https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-09. ĐIỀU TRỊ GIÃN LỖ CHÂN LÔNG BẰNG LĂN KIM VÀ SẢN PHẨM TỪ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Tạo vi tổn thương có kiểm soát. Các tên "tế bào gốc", "exosome" không đồng nghĩa; không được mặc định là sản phẩm an toàn dùng trên da bị phá vỡ hàng rào. Hiệu quả phụ thuộc chỉ định và bằng chứng của kỹ thuật/sản phẩm.

2. CHỈ ĐỊNH

Nhu cầu cải thiện cấu trúc da được khám và chỉ định.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nhiễm trùng, mụn viêm hoạt động hoặc tổn thương nghi ác tính tại vùng thao tác; không dùng sản phẩm chưa xác minh tính hợp pháp, vô khuẩn và đường sử dụng.

4. THẬN TRỌNG

Nguy cơ tăng sắc tố, sẹo, rối loạn đông máu, cơ địa sẹo lồi, bệnh nền và thuốc đang dùng. Không cam kết làm biến mất lỗ chân lông; đánh giá bệnh da đang hoạt động.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Bác sĩ xác lập chẩn đoán, loại trừ bệnh không phù hợp và ghi mục tiêu, vùng điều trị.

6.2. Bước 2

Xác nhận thiết bị, kim vô khuẩn dùng một lần; nếu phối hợp sản phẩm phải ghi tên, thành phần, số lô, hạn dùng, đường dùng và tài liệu cho phép.

6.3. Bước 3

Làm sạch; gây tê khi có y lệnh, tính tổng liều; loại bỏ thuốc tê, sát khuẩn phù hợp và chờ khô.

6.4. Bước 4

Cài độ sâu, tốc độ hoặc lực thao tác theo vùng và hướng dẫn thiết bị đã được bác sĩ xác nhận; không áp dụng một độ sâu cho mọi vị trí.

6.5. Bước 5

Thao tác từng vùng có kiểm soát, theo dõi đau và tổn thương; không cố tạo chảy máu làm điểm kết thúc.

6.6. Bước 6

Chỉ dùng sản phẩm phối hợp khi đã đủ điều kiện ở bước kiểm tra; nếu chưa đủ, dừng phần phối hợp và báo bác sĩ, không tự thay sản phẩm.

6.7. Bước 7

Làm sạch nhẹ, chăm sóc thích hợp, đánh giá trước rời phòng; bỏ kim vào hộp vật sắc nhọn.

6.8. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Hướng dẫn vệ sinh, chống nắng khi da dung nạp; tránh trang điểm và chất kích ứng đến khi hàng rào da hồi phục. Báo đau tăng, mủ, đỏ lan, sốt hoặc tăng sắc tố. Không ấn định mọi người được trang điểm sau 12 giờ.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

FDA. Microneedling devices: nguy cơ và giới hạn sử dụng phối hợp sản phẩm. Đây là nguồn cảnh báo an toàn của Hoa Kỳ, không thay thế quy định lưu hành tại Việt Nam. https://www.fda.gov/medical-devices/aesthetic-cosmetic-devices/microneedling-devices

CDC. Safe injection practices. https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-10. ĐIỀU TRỊ LÃO HÓA DA BẰNG LĂN KIM VÀ SẢN PHẨM TỪ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Tạo vi tổn thương có kiểm soát. Các tên "tế bào gốc", "exosome" không đồng nghĩa; không được mặc định là sản phẩm an toàn dùng trên da bị phá vỡ hàng rào. Hiệu quả phụ thuộc chỉ định và bằng chứng của kỹ thuật/sản phẩm.

2. CHỈ ĐỊNH

Lão hóa da được bác sĩ đánh giá phù hợp can thiệp.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nhiễm trùng, mụn viêm hoạt động hoặc tổn thương nghi ác tính tại vùng thao tác; không dùng sản phẩm chưa xác minh tính hợp pháp, vô khuẩn và đường sử dụng.

4. THẬN TRỌNG

Nguy cơ tăng sắc tố, sẹo, rối loạn đông máu, cơ địa sẹo lồi, bệnh nền và thuốc đang dùng. Đánh giá độ mỏng da, tổn thương ánh sáng và tổn thương tiền ung thư.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Bác sĩ xác lập chẩn đoán, loại trừ bệnh không phù hợp và ghi mục tiêu, vùng điều trị.

6.2. Bước 2

Xác nhận thiết bị, kim vô khuẩn dùng một lần; nếu phối hợp sản phẩm phải ghi tên, thành phần, số lô, hạn dùng, đường dùng và tài liệu cho phép.

6.3. Bước 3

Làm sạch; gây tê khi có y lệnh, tính tổng liều; loại bỏ thuốc tê, sát khuẩn phù hợp và chờ khô.

6.4. Bước 4

Cài độ sâu, tốc độ hoặc lực thao tác theo vùng và hướng dẫn thiết bị đã được bác sĩ xác nhận; không áp dụng một độ sâu cho mọi vị trí.

6.5. Bước 5

Thao tác từng vùng có kiểm soát, theo dõi đau và tổn thương; không cố tạo chảy máu làm điểm kết thúc.

6.6. Bước 6

Chỉ dùng sản phẩm phối hợp khi đã đủ điều kiện ở bước kiểm tra; nếu chưa đủ, dừng phần phối hợp và báo bác sĩ, không tự thay sản phẩm.

6.7. Bước 7

Làm sạch nhẹ, chăm sóc thích hợp, đánh giá trước rời phòng; bỏ kim vào hộp vật sắc nhọn.

6.8. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Hướng dẫn vệ sinh, chống nắng khi da dung nạp; tránh trang điểm và chất kích ứng đến khi hàng rào da hồi phục. Báo đau tăng, mủ, đỏ lan, sốt hoặc tăng sắc tố. Không ấn định mọi người được trang điểm sau 12 giờ.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

FDA. Microneedling devices: nguy cơ và giới hạn sử dụng phối hợp sản phẩm. Đây là nguồn cảnh báo an toàn của Hoa Kỳ, không thay thế quy định lưu hành tại Việt Nam. https://www.fda.gov/medical-devices/aesthetic-cosmetic-devices/microneedling-devices

CDC. Safe injection practices. https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-11. HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TRỨNG CÁ BẰNG ĐÈN LED

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Quang trị liệu LED hỗ trợ một số trường hợp trứng cá; không đồng nhất với quang động trị liệu dùng chất cảm quang.

2. CHỈ ĐỊNH

Trứng cá có chỉ định bổ trợ của bác sĩ.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định theo hướng dẫn thiết bị; không kiểm soát được nguy cơ nhạy sáng hoặc bảo vệ mắt.

4. THẬN TRỌNG

Thuốc và bệnh nhạy sáng; đánh giá bằng chứng hiệu quả, không thay thế phác đồ thuốc cần thiết.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Xác nhận bước sóng, chế độ, cường độ và thời gian theo đúng máy và y lệnh.

6.2. Bước 2

Làm sạch da; không bôi kem chống nắng hay sản phẩm cản quang trước chiếu trừ khi hướng dẫn máy cho phép.

6.3. Bước 3

Bảo vệ mắt phù hợp phổ LED thực tế, bao gồm ánh sáng xanh khi sử dụng; không dùng mặc định kính IPL 500–1200 nm.

6.4. Bước 4

Đặt khoảng cách theo hướng dẫn máy, bắt đầu chiếu; theo dõi đau, nóng, khó chịu mắt và nhức đầu.

6.5. Bước 5

Dừng khi bất thường; đánh giá da và mắt, ghi thời gian thực chiếu và đáp ứng.

6.6. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-

BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Chăm sóc da và chống nắng sau điều trị; triệu chứng mắt hoặc nhức đầu kéo dài cần khám. Không mặc định khoảng cách 4–8 cm hay 20 phút cho mọi máy.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

American Academy of Dermatology. Hướng dẫn điều trị trứng cá 2024; bằng chứng cho một số kỹ thuật hỗ trợ còn hạn chế. https://www.aad.org/member/clinical-quality/guidelines/acne/

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-12. ĐIỀU TRỊ RỤNG TÓC BẰNG LĂN KIM VÀ SẢN PHẨM TỪ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Tạo vi tổn thương có kiểm soát. Các tên "tế bào gốc", "exosome" không đồng nghĩa; không được mặc định là sản phẩm an toàn dùng trên da bị phá vỡ hàng rào. Hiệu quả phụ thuộc chỉ định và bằng chứng của kỹ thuật/sản phẩm.

2. CHỈ ĐỊNH

Rụng tóc có nguyên nhân được bác sĩ đánh giá phù hợp kỹ thuật hỗ trợ.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nhiễm trùng, mụn viêm hoạt động hoặc tổn thương nghi ác tính tại vùng thao tác; không dùng sản phẩm chưa xác minh tính hợp pháp, vô khuẩn và đường sử dụng.

4. THẬN TRỌNG

Nguy cơ tăng sắc tố, sẹo, rối loạn đông máu, cơ địa sẹo lồi, bệnh nền và thuốc đang dùng. Nếu là hói kiểu androgen, đối chiếu quy trình bệnh hói để tránh chỉ định trùng; tìm nguyên nhân toàn thân và bệnh da đầu trước điều trị.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Bác sĩ xác lập chẩn đoán, loại trừ bệnh không phù hợp và ghi mục tiêu, vùng điều trị.

6.2. Bước 2

Xác nhận thiết bị, kim vô khuẩn dùng một lần; nếu phối hợp sản phẩm phải ghi tên, thành phần, số lô, hạn dùng, đường dùng và tài liệu cho phép.

6.3. Bước 3

Làm sạch; gây tê khi có y lệnh, tính tổng liều; loại bỏ thuốc tê, sát khuẩn phù hợp và chờ khô.

6.4. Bước 4

Cài độ sâu, tốc độ hoặc lực thao tác theo vùng và hướng dẫn thiết bị đã được bác sĩ xác nhận; không áp dụng một độ sâu cho mọi vị trí.

6.5. Bước 5

Thao tác từng vùng có kiểm soát, theo dõi đau và tổn thương; không cố tạo chảy máu làm điểm kết thúc.

6.6. Bước 6

Chỉ dùng sản phẩm phối hợp khi đã đủ điều kiện ở bước kiểm tra; nếu chưa đủ, dừng phần phối hợp và báo bác sĩ, không tự thay sản phẩm.

6.7. Bước 7

Làm sạch nhẹ, chăm sóc thích hợp, đánh giá trước rời phòng; bỏ kim vào hộp vật sắc nhọn.

6.8. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Hướng dẫn vệ sinh, chống nắng khi da dung nạp; tránh trang điểm và chất kích ứng đến khi hàng rào da hồi phục. Báo đau tăng, mủ, đỏ lan, sốt hoặc tăng sắc tố. Không ấn định mọi người được trang điểm sau 12 giờ.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

FDA. Microneedling devices: nguy cơ và giới hạn sử dụng phối hợp sản phẩm. Đây là nguồn cảnh báo an toàn của Hoa Kỳ, không thay thế quy định lưu hành tại Việt Nam. https://www.fda.gov/medical-devices/aesthetic-cosmetic-devices/microneedling-devices

CDC. Safe injection practices. https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-13. ĐIỀU TRỊ SẸO LỒI BẰNG TIÊM TRIAMCINOLONE TRONG TỔN THƯƠNG

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Bác sĩ tiêm triamcinolone trong tổn thương theo đúng chế phẩm, đường dùng và kế hoạch liều. Điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ, theo dõi trong phạm vi được giao.

2. CHỈ ĐỊNH

Sẹo lồi/sẹo phì đại được bác sĩ chỉ định tiêm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Dị ứng thành phần; nhiễm trùng chưa kiểm soát tại điểm tiêm; chống chỉ định của đúng nhãn thuốc.

4. THẬN TRỌNG

Đái tháo đường, bệnh nền, nguy cơ tác dụng toàn thân, teo da và thay đổi sắc tố. Bỏ công thức nguồn vừa ghi 16 mg/ml vừa ghi pha thành 20–40 mg/ml; pha loãng không thể tăng nồng độ.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Xác nhận tổn thương, vị trí và chỉ định; ghi nồng độ, thể tích từng vị trí, tổng thể tích và tổng liều mg cho buổi.

6.2. Bước 2

Kiểm tra đúng chế phẩm được phép dùng trong tổn thương, số lô, hạn dùng; không mặc định mọi lọ 40 mg/ml có cùng đường dùng.

6.3. Bước 3

Nếu pha loãng, bác sĩ/dược sĩ xác nhận dung môi tương hợp; tính theo C ban đầu × V ban đầu = C sau pha × V sau pha, kiểm tra độc lập và ghi nhãn.

6.4. Bước 4

Sát khuẩn, để khô; bác sĩ tiêm đúng lớp tổn thương, tránh mô lành và mạch máu, kiểm soát thể tích theo y lệnh.

6.5. Bước 5

Theo dõi tại chỗ và toàn thân; kiểm tra cầm máu, ghi liều thực dùng và phần thuốc xử lý.

6.6. Bước 6

Hẹn đánh giá đáp ứng và tác dụng không mong muốn trước quyết định buổi tiếp theo.

6.7. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi teo da, giãn mạch, giảm sắc tố, loét, nhiễm trùng và tác dụng steroid toàn thân. Không áp dụng trần 80 mg cho mọi người bệnh hoặc mọi bệnh lý.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

DailyMed. Kenalog-10, nhãn triamcinolone dùng trong tổn thương. Chỉ tham khảo nguyên tắc an toàn; phải đối chiếu đúng nhãn thuốc đang sử dụng tại bệnh viện. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=ec04ecbb-2896-3feb-85fd-a64aba93b289

CDC. Safe injection practices. https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-14. ĐIỀU TRỊ DA BẰNG HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU TỰ THÂN (PRP)

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Sử dụng PRP tự thân theo chỉ định đã được bệnh viện phê duyệt; mức độ bằng chứng khác nhau giữa các mục đích.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có chỉ định phù hợp danh mục và được giải thích lựa chọn khác.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không đủ điều kiện nhận diện, chất lượng PRP hoặc điều kiện vô khuẩn; chống chỉ định lâm sàng của kỹ thuật và bộ kit.

4. THẬN TRỌNG

Bệnh máu, thuốc chống đông, nhiễm trùng, thiếu máu, bệnh nền; bác sĩ đánh giá, không yêu cầu tự ngừng thuốc.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Xác nhận chỉ định, vùng, đường sử dụng và đồng ý; đánh giá nguy cơ.

6.2. Bước 2

Nhận PRP từ quy trình tách PRP: đối chiếu hai định danh, thời gian, kit, điều kiện bảo quản và tiêu chí xuất dùng.

6.3. Bước 3

Kiểm tra tính toàn vẹn và chất lượng theo hướng dẫn kit; không dùng khi sai nhãn, nghi nhiễm bẩn hoặc quá thời hạn.

6.4. Bước 4

Chuẩn bị vùng vô khuẩn và gây tê khi chỉ định; bác sĩ sử dụng đúng đường đã xác nhận, không tự đổi giữa tiêm và bôi qua lăn kim.

6.5. Bước 5

Không pha thêm mỹ phẩm hoặc chất khác khi chưa xác nhận tính tương hợp và phép sử dụng.

6.6. Bước 6

Theo dõi, ghi thể tích thực dùng, vị trí, đường dùng và toàn bộ truy xuất bộ kit.

6.7. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi chảy máu, đau, nhiễm trùng và phản ứng tại chỗ; không bảo đảm hiệu quả trẻ hóa. Chỉ hẹn buổi tiếp theo sau đánh giá bác sĩ.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

CDC MMWR 2024. Điều tra lây truyền HIV liên quan dịch vụ PRP và lăn kim; nhấn mạnh kiểm soát nhiễm khuẩn và nhận diện bệnh phẩm. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/73/wr/mm7316a3.htm

CDC. Safe injection practices. https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

FDA. Microneedling devices: nguy cơ và giới hạn sử dụng phối hợp sản phẩm. Đây là nguồn cảnh báo an toàn của Hoa Kỳ, không thay thế quy định lưu hành tại Việt Nam. https://www.fda.gov/medical-devices/aesthetic-cosmetic-devices/microneedling-devices

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-15. ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ BẰNG LASER CO_2

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Bác sĩ phá hủy tổn thương đã chẩn đoán bằng laser CO_2 trong phạm vi kỹ thuật được phép.

2. CHỈ ĐỊNH

Sùi mào gà được bác sĩ lựa chọn laser.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tổn thương chưa loại trừ ác tính; không có điều kiện kiểm soát khói, cháy hoặc bảo vệ mắt theo thiết bị.

4. THẬN TRỌNG

Đánh giá bệnh nền, đông máu, liền thương và cơ địa sẹo. Không coi mọi máy tạo nhịp là chống chỉ định của laser; nếu phối hợp điện phẫu cần kiểm tra riêng. Bảo vệ riêng tư, tư vấn bệnh lây truyền qua tình dục. Điều trị tổn thương nhìn thấy không bảo đảm loại bỏ HPV; không dùng sát khuẩn không phù hợp lên niêm mạc.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Khám, đánh dấu tổn thương; lấy bệnh phẩm trước phá hủy nếu cần chẩn đoán mô học.

6.2. Bước 2

Kiểm tra máy CO_2, đầu phát, thông số chỉ định, kính bảo vệ phù hợp 10.600 nm và phương tiện bảo vệ vùng lân cận.

6.3. Bước 3

Bố trí hút khói tại nguồn với lọc phù hợp; thực hiện bảo hộ theo đánh giá nguy cơ. Kiểm soát chất dễ cháy và oxy; sát khuẩn phải khô, không đọng dung dịch.

6.4. Bước 4

Gây tê theo y lệnh, tính tổng liều; bác sĩ đánh giá hiệu lực trước can thiệp.

6.5. Bước 5

Bác sĩ phát tia có kiểm soát theo từng tổn thương, đánh giá độ sâu và cầm máu; hút khói đồng thời; dừng khi vượt độ sâu hoặc phản ứng bất thường.

6.6. Bước 6

Đưa máy về chế độ an toàn, kiểm tra vết thương, chăm sóc/băng phù hợp và ghi thông số thực dùng.

6.7. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi chảy máu, bỏng, tổn thương mắt, nhiễm trùng, chậm liền, thay đổi sắc tố, sẹo và tái phát. Đau mắt hoặc giảm thị lực cần khám chuyên khoa khẩn. Không kê kháng sinh thường quy cho mọi vết thương sạch.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

NIOSH. Control of smoke from laser/electric surgical procedures. https://www.cdc.gov/niosh/docs/hazardcontrol/hc11.html

CDC. Anogenital warts, STI treatment guidelines. https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/anogenital-warts.htm

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-16. ĐIỀU TRỊ RỤNG TÓC TỪNG VÙNG BẰNG TIÊM TRIAMCINOLONE TRONG TỔN THƯƠNG

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Bác sĩ tiêm triamcinolone trong tổn thương theo đúng chế phẩm, đường dùng và kế hoạch liều. Điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ, theo dõi trong phạm vi được giao.

2. CHỈ ĐỊNH

Rụng tóc từng vùng được bác sĩ chẩn đoán và lựa chọn tiêm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Dị ứng thành phần; nhiễm trùng chưa kiểm soát tại điểm tiêm; chống chỉ định của đúng nhãn thuốc.

4. THẬN TRỌNG

Đái tháo đường, bệnh nền, nguy cơ tác dụng toàn thân, teo da và thay đổi sắc tố. Phân biệt nấm, rụng tóc sẹo và hói androgen; đánh giá riêng vùng lông mày. Tiêm đúng lớp tổn thương, tránh tiêm sâu vào mô dưới da gây teo.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Xác nhận tổn thương, vị trí và chỉ định; ghi nồng độ, thể tích từng vị trí, tổng thể tích và tổng liều mg cho buổi.

6.2. Bước 2

Kiểm tra đúng chế phẩm được phép dùng trong tổn thương, số lô, hạn dùng; không mặc định mọi lọ 40 mg/ml có cùng đường dùng.

6.3. Bước 3

Nếu pha loãng, bác sĩ/dược sĩ xác nhận dung môi tương hợp; tính theo C ban đầu × V ban đầu = C sau pha × V sau pha, kiểm tra độc lập và ghi nhãn.

6.4. Bước 4

Sát khuẩn, để khô; bác sĩ tiêm đúng lớp tổn thương, tránh mô lành và mạch máu, kiểm soát thể tích theo y lệnh.

6.5. Bước 5

Theo dõi tại chỗ và toàn thân; kiểm tra cầm máu, ghi liều thực dùng và phần thuốc xử lý.

6.6. Bước 6

Hẹn đánh giá đáp ứng và tác dụng không mong muốn trước quyết định buổi tiếp theo.

6.7. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi teo da, giãn mạch, giảm sắc tố, loét, nhiễm trùng và tác dụng steroid toàn thân. Không áp dụng trần 80 mg cho mọi người bệnh hoặc mọi bệnh lý.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

DailyMed. Kenalog-10, nhãn triamcinolone dùng trong tổn thương. Chỉ tham khảo nguyên tắc an toàn; phải đối chiếu đúng nhãn thuốc đang sử dụng tại bệnh viện. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=ec04ecbb-2896-3feb-85fd-a64aba93b289

CDC. Safe injection practices. https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-17. ĐIỀU TRỊ SẸO LÕM BẰNG TÁCH ĐÁY SẸO

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Giải phóng dải xơ giữ đáy sẹo; bác sĩ thực hiện thủ thuật xâm lấn.

2. CHỈ ĐỊNH

Sẹo lõm có dải xơ phù hợp tách đáy theo đánh giá bác sĩ.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nhiễm trùng tại vùng can thiệp; rối loạn đông máu chưa xử trí; điều kiện vô khuẩn hoặc nhân lực không đáp ứng.

4. THẬN TRỌNG

Vùng có mạch, thần kinh quan trọng; nguy cơ tụ máu, sẹo và tổn thương thần kinh.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Khám và xác định sẹo phù hợp; đánh dấu vùng, đánh giá cấu trúc giải phẫu và chụp ảnh được đồng ý.

6.2. Bước 2

Chuẩn bị trường vô khuẩn; chọn dụng cụ phù hợp và phương án gây tê có kiểm tra tổng liều.

6.3. Bước 3

Bác sĩ tạo điểm vào, đưa dụng cụ đúng lớp và giải phóng dải xơ có kiểm soát; không tìm tiếng kêu làm điểm kết thúc.

6.4. Bước 4

Dừng khi đau dữ dội, chảy máu bất thường hoặc nghi tổn thương thần kinh/mạch; xử trí theo đánh giá.

6.5. Bước 5

Rút dụng cụ, ép cầm máu, kiểm tra tụ máu và chức năng vùng; băng phù hợp.

6.6. Bước 6

Ghi vùng, dụng cụ, gây tê, mức can thiệp, đáp ứng và kế hoạch theo dõi.

6.7. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-

BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi tụ máu tăng, đau, rối loạn cảm giác, nhiễm trùng và sẹo. Không cam kết đầy sẹo sau một thời gian cố định; phối hợp PRP phải có chỉ định riêng.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

CDC. Safe injection practices. https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

AAD. Skin biopsy wound care. https://www.aad.org/public/diseases/a-z/skin-biopsy-wound-care

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-18. PHI KIM BẰNG BÚT ĐIỀU TRỊ TRẺ HÓA DA

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Tạo vi tổn thương có kiểm soát. Các tên "tế bào gốc", "exosome" không đồng nghĩa; không được mặc định là sản phẩm an toàn dùng trên da bị phá vỡ hàng rào. Hiệu quả phụ thuộc chỉ định và bằng chứng của kỹ thuật/sản phẩm.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh được bác sĩ lựa chọn phi kim theo tình trạng da.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nhiễm trùng, mụn viêm hoạt động hoặc tổn thương nghi ác tính tại vùng thao tác; không dùng sản phẩm chưa xác minh tính hợp pháp, vô khuẩn và đường sử dụng.

4. THẬN TRỌNG

Nguy cơ tăng sắc tố, sẹo, rối loạn đông máu, cơ địa sẹo lồi, bệnh nền và thuốc đang dùng. Đây là kỹ thuật xâm lấn hàng rào da; thông số của bút phải theo đúng cartridge và hướng dẫn máy.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Bác sĩ xác lập chẩn đoán, loại trừ bệnh không phù hợp và ghi mục tiêu, vùng điều trị.

6.2. Bước 2

Xác nhận thiết bị, kim vô khuẩn dùng một lần; nếu phối hợp sản phẩm phải ghi tên, thành phần, số lô, hạn dùng, đường dùng và tài liệu cho phép.

6.3. Bước 3

Làm sạch; gây tê khi có y lệnh, tính tổng liều; loại bỏ thuốc tê, sát khuẩn phù hợp và chờ khô.

6.4. Bước 4

Cài độ sâu, tốc độ hoặc lực thao tác theo vùng và hướng dẫn thiết bị đã được bác sĩ xác nhận; không áp dụng một độ sâu cho mọi vị trí.

6.5. Bước 5

Thao tác từng vùng có kiểm soát, theo dõi đau và tổn thương; không cố tạo chảy máu làm điểm kết thúc.

6.6. Bước 6

Chỉ dùng sản phẩm phối hợp khi đã đủ điều kiện ở bước kiểm tra; nếu chưa đủ, dừng phần phối hợp và báo bác sĩ, không tự thay sản phẩm.

6.7. Bước 7

Làm sạch nhẹ, chăm sóc thích hợp, đánh giá trước rời phòng; bỏ kim vào hộp vật sắc nhọn.

6.8. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Hướng dẫn vệ sinh, chống nắng khi da dung nạp; tránh trang điểm và chất kích ứng đến khi hàng rào da hồi phục. Báo đau tăng, mủ, đỏ lan, sốt hoặc tăng sắc tố. Không ấn định mọi người được trang điểm sau 12 giờ.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

FDA. Microneedling devices: nguy cơ và giới hạn sử dụng phối hợp sản phẩm. Đây là nguồn cảnh báo an toàn của Hoa Kỳ, không thay thế quy định lưu hành tại Việt Nam. https://www.fda.gov/medical-devices/aesthetic-cosmetic-devices/microneedling-devices

CDC. Safe injection practices. https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-19. SINH THIẾT DA

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Lấy bệnh phẩm da phục vụ chẩn đoán; phương pháp và bảo quản phải phù hợp xét nghiệm.

2. CHỈ ĐỊNH

Tổn thương cần mô bệnh học, miễn dịch huỳnh quang hoặc xét nghiệm khác theo bác sĩ.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không đủ điều kiện vô khuẩn hoặc xử trí chảy máu; chống chỉ định tương đối được bác sĩ cân nhắc lợi ích/nguy cơ.

4. THẬN TRỌNG

Thuốc chống đông, vị trí giải phẫu, nguy cơ sẹo; nhiễm trùng không phải chống chỉ định tuyệt đối nếu sinh thiết để chẩn đoán chính bệnh nhiễm trùng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Bác sĩ lựa chọn vị trí và phương pháp punch, shave, sinh thiết một phần hoặc toàn bộ phù hợp câu hỏi chẩn đoán.

6.2. Bước 2

Liên hệ phòng xét nghiệm trước lấy mẫu nếu cần miễn dịch huỳnh quang, vi sinh hoặc xét nghiệm đặc biệt; chuẩn bị đúng lọ và môi trường.

6.3. Bước 3

Sát khuẩn, gây tê đúng liều; bác sĩ lấy mẫu đúng kích thước và độ sâu, hạn chế dập mô.

6.4. Bước 4

Cầm máu và đóng/băng vết thương theo vị trí; kiểm đếm vật sắc nhọn.

6.5. Bước 5

Cho bệnh phẩm mô học vào formalin đệm trung tính 10% khi phù hợp. Mẫu miễn dịch huỳnh quang/vi sinh phải dùng môi trường hoặc mẫu tươi theo xét nghiệm, không mặc định formalin.

6.6. Bước 6

Ghi nhãn ngay: hai định danh, vị trí/bên, thời gian, loại mẫu; hoàn thiện phiếu có bệnh sử, chẩn đoán và xét nghiệm yêu cầu; bàn giao có xác nhận.

6.7. Bước 7

Ghi thủ thuật, hẹn chăm sóc/cắt chỉ khi cần; theo dõi kết quả đến khi bác sĩ đã nhận và thông báo kế hoạch cho người bệnh.

6.8. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Chăm sóc vết thương sạch, theo dõi chảy máu và nhiễm trùng; không dùng kháng sinh hoặc oxy già thường quy. Kiểm soát phơi nhiễm formalin và không để mất dấu kết quả xét nghiệm.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

RCPA Manual. Skin biopsy: lựa chọn bệnh phẩm và môi trường bảo quản theo xét nghiệm. https://www.rcpa.edu.au/Manuals/RCPA-Manual/Pathology-Tests/S/Skin-biopsy

AAD. Skin biopsy wound care. https://www.aad.org/public/diseases/a-z/skin-biopsy-wound-care

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-20. TÁCH HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU TỰ THÂN (PRP)

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Chuẩn bị chế phẩm tự thân bằng bộ kit và máy tương thích; không khẳng định nồng độ tiểu cầu nếu chưa đo.

2. CHỈ ĐỊNH

Có y lệnh chuẩn bị PRP cho chính người bệnh đủ điều kiện sử dụng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có kit/thiết bị phù hợp hoặc không đủ điều kiện nhận diện và vô khuẩn; chống chỉ định người bệnh theo bác sĩ và kit.

4. THẬN TRỌNG

Nhận diện nhầm, tan máu, đông mẫu, lây nhiễm; mỗi lần chỉ xử lý bệnh phẩm của một người bệnh tại khu vực quy định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Kiểm tra y lệnh, hai định danh và điều kiện lấy máu; chọn kit, chất chống đông, thể tích theo hướng dẫn đã xác nhận.

6.2. Bước 2

Lấy máu vô khuẩn bằng vật tư dùng một lần, ghi nhãn ngay trước rời người bệnh; không để ống không nhãn.

6.3. Bước 3

Kiểm tra tính toàn vẹn, loại ống và khả năng tương thích máy; cân bằng rotor, đóng khóa nắp.

6.4. Bước 4

Cài chương trình ly tâm đúng kit và rotor: ghi RCF hoặc rpm, thời gian và bán kính khi cần; không mặc định 830 g bằng 2.500 rpm.

6.5. Bước 5

Thu phân đoạn theo hướng dẫn kit bằng thao tác vô khuẩn; ghi thể tích và kết quả chất lượng nếu có.

6.6. Bước 6

Hoạt hóa chỉ khi hướng dẫn kit và y lệnh yêu cầu; ghi đúng chất, nồng độ, tỷ lệ. Không mặc định natri clorua 1 ml là công thức hoạt hóa, cũng không tự đổi sang chất khác.

6.7. Bước 7

Kiểm tra điều kiện xuất dùng, nhãn, thời hạn/bảo quản; bàn giao PRP cùng hồ sơ cho người sử dụng, đối chiếu hai định danh.

6.8. Bước 8

Xử lý phần dư, vật sắc nhọn và chất thải; khử khuẩn thiết bị đúng hướng dẫn, ghi truy xuất lô và sự cố.

6.9. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Không xuất dùng chế phẩm sai nhãn, nghi nhiễm bẩn, hỏng ống hoặc không đạt tiêu chí kit. Khi vỡ ống, dừng máy theo hướng dẫn và xử lý phơi nhiễm, không mở máy đang quay.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

CDC MMWR 2024. Điều tra lây truyền HIV liên quan dịch vụ PRP và lăn kim; nhấn mạnh kiểm soát nhiễm khuẩn và nhận diện bệnh phẩm. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/73/wr/mm7316a3.htm

CDC. Safe injection practices. https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-21. TIÊM VI ĐIỂM (MESOTHERAPY)

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Tiêm sản phẩm xác định theo chỉ định và đường dùng được phép; không sử dụng "cocktail" mỹ phẩm tùy ý.

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ định cụ thể được bác sĩ xác lập cho sản phẩm và kỹ thuật được phép.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Dị ứng; nhiễm trùng tại vùng tiêm; sản phẩm không xác minh được phép tiêm hoặc thiếu thông tin đường dùng.

4. THẬN TRỌNG

Rối loạn đông máu, bệnh nền, vùng nguy cơ mạch/mắt; bằng chứng khác nhau theo sản phẩm và chỉ định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Xác nhận chẩn đoán, vùng, tên và thành phần sản phẩm, phép lưu hành, đường dùng, số lô, hạn dùng.

6.2. Bước 2

Bác sĩ ghi lớp tiêm, liều/thể tích từng điểm, tổng liều, khoảng cách và phương án theo dõi; không tự pha trộn.

6.3. Bước 3

Chuẩn bị vô khuẩn, sát khuẩn để khô, chọn kim dùng một lần; gây tê khi được chỉ định.

6.4. Bước 4

Bác sĩ tiêm từng điểm đúng lớp theo kế hoạch, kiểm soát lượng thực tiêm.

6.5. Bước 5

Dừng ngay khi đau dữ dội, trắng bệch, da dạng lưới hoặc thay đổi thị lực; gọi bác sĩ, xử trí thiếu máu/tổn thương mắt theo sản phẩm và quy trình chuyên khoa.

6.6. Bước 6

Kiểm tra tại chỗ và toàn thân, ghi đầy đủ tổng lượng thực dùng và truy xuất sản phẩm.

6.7. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi nhiễm trùng muộn, nốt dai dẳng, áp xe và rối loạn sắc tố; cần khám và xét nghiệm phù hợp khi nghi nhiễm trùng không điển hình. Không tự dùng kháng sinh, steroid hoặc thuốc giải cho mọi sản phẩm.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

CDC. Safe injection practices. https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-guidance/

FDA. Microneedling devices: nguy cơ và giới hạn sử dụng phối hợp sản phẩm. Đây là nguồn cảnh báo an toàn của Hoa Kỳ, không thay thế quy định lưu hành tại Việt Nam.
https://www.fda.gov/medical-devices/aesthetic-cosmetic-devices/microneedling-devices

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-22. ĐIỀU TRỊ U ỐNG TUYẾN MỒ HÔI BẰNG LASER CO_2

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Bác sĩ phá hủy tổn thương đã chẩn đoán bằng laser CO_2 trong phạm vi kỹ thuật được phép.

2. CHỈ ĐỊNH

U ống tuyến mồ hôi có chẩn đoán được lựa chọn laser.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tổn thương chưa loại trừ ác tính; không có điều kiện kiểm soát khói, cháy hoặc bảo vệ mắt theo thiết bị.

4. THẬN TRỌNG

Đánh giá bệnh nền, đông máu, liền thương và cơ địa sẹo. Không coi mọi máy tạo nhịp là chống chỉ định của laser; nếu phối hợp điện phẫu cần kiểm tra riêng. Tổn thương quanh mắt phải có bảo vệ nhãn cầu phù hợp và người thực hiện được đào tạo; kính ngoài không đủ cho mọi vị trí.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Khám, đánh dấu tổn thương; lấy bệnh phẩm trước phá hủy nếu cần chẩn đoán mô học.

6.2. Bước 2

Kiểm tra máy CO_2, đầu phát, thông số chỉ định, kính bảo vệ phù hợp 10.600 nm và phương tiện bảo vệ vùng lân cận.

6.3. Bước 3

Bố trí hút khói tại nguồn với lọc phù hợp; thực hiện bảo hộ theo đánh giá nguy cơ. Kiểm soát chất dễ cháy và oxy; sát khuẩn phải khô, không đọng dung dịch.

6.4. Bước 4

Gây tê theo y lệnh, tính tổng liều; bác sĩ đánh giá hiệu lực trước can thiệp.

6.5. Bước 5

Bác sĩ phát tia có kiểm soát theo từng tổn thương, đánh giá độ sâu và cầm máu; hút khói đồng thời; dừng khi vượt độ sâu hoặc phản ứng bất thường.

6.6. Bước 6

Đưa máy về chế độ an toàn, kiểm tra vết thương, chăm sóc/băng phù hợp và ghi thông số thực dùng.

6.7. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi chảy máu, bỏng, tổn thương mắt, nhiễm trùng, chậm liền, thay đổi sắc tố, sẹo và tái phát. Đau mắt hoặc giảm thị lực cần khám chuyên khoa khẩn. Không kê kháng sinh thường quy cho mọi vết thương sạch.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

NIOSH. Control of smoke from laser/electric surgical procedures. https://www.cdc.gov/niosh/docs/hazardcontrol/hc11.html

AAD. Skin biopsy wound care. https://www.aad.org/public/diseases/a-z/skin-biopsy-wound-care

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-23. ĐIỀU TRỊ U MỀM TREO BẰNG LASER CO_2

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Bác sĩ phá hủy tổn thương đã chẩn đoán bằng laser CO_2 trong phạm vi kỹ thuật được phép.

2. CHỈ ĐỊNH

U mềm treo có chẩn đoán, có nhu cầu/chỉ định can thiệp.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tổn thương chưa loại trừ ác tính; không có điều kiện kiểm soát khói, cháy hoặc bảo vệ mắt theo thiết bị.

4. THẬN TRỌNG

Đánh giá bệnh nền, đông máu, liền thương và cơ địa sẹo. Không coi mọi máy tạo nhịp là chống chỉ định của laser; nếu phối hợp điện phẫu cần kiểm tra riêng. Loại trừ tổn thương khác trước phá hủy.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Khám, đánh dấu tổn thương; lấy bệnh phẩm trước phá hủy nếu cần chẩn đoán mô học.

6.2. Bước 2

Kiểm tra máy CO_2, đầu phát, thông số chỉ định, kính bảo vệ phù hợp 10.600 nm và phương tiện bảo vệ vùng lân cận.

6.3. Bước 3

Bố trí hút khói tại nguồn với lọc phù hợp; thực hiện bảo hộ theo đánh giá nguy cơ. Kiểm soát chất dễ cháy và oxy; sát khuẩn phải khô, không đọng dung dịch.

6.4. Bước 4

Gây tê theo y lệnh, tính tổng liều; bác sĩ đánh giá hiệu lực trước can thiệp.

6.5. Bước 5

Bác sĩ phát tia có kiểm soát theo từng tổn thương, đánh giá độ sâu và cầm máu; hút khói đồng thời; dừng khi vượt độ sâu hoặc phản ứng bất thường.

6.6. Bước 6

Đưa máy về chế độ an toàn, kiểm tra vết thương, chăm sóc/băng phù hợp và ghi thông số thực dùng.

6.7. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi chảy máu, bỏng, tổn thương mắt, nhiễm trùng, chậm liền, thay đổi sắc tố, sẹo và tái phát. Đau mắt hoặc giảm thị lực cần khám chuyên khoa khẩn. Không kê kháng sinh thường quy cho mọi vết thương sạch.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

NIOSH. Control of smoke from laser/electric surgical procedures. https://www.cdc.gov/niosh/docs/hazardcontrol/hc11.html

AAD. Skin biopsy wound care. https://www.aad.org/public/diseases/a-z/skin-biopsy-wound-care

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-24. ĐIỀU TRỊ DÀY SỪNG DA DẦU BẰNG LASER CO_2

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Bác sĩ phá hủy tổn thương đã chẩn đoán bằng laser CO_2 trong phạm vi kỹ thuật được phép.

2. CHỈ ĐỊNH

Dày sừng da dầu đã được xác định lành tính và có chỉ định.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tổn thương chưa loại trừ ác tính; không có điều kiện kiểm soát khói, cháy hoặc bảo vệ mắt theo thiết bị.

4. THẬN TRỌNG

Đánh giá bệnh nền, đông máu, liền thương và cơ địa sẹo. Không coi mọi máy tạo nhịp là chống chỉ định của laser; nếu phối hợp điện phẫu cần kiểm tra riêng. Tổn thương sắc tố bất thường phải đánh giá chẩn đoán trước; không phá hủy tổn thương nghi ung thư.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Khám, đánh dấu tổn thương; lấy bệnh phẩm trước phá hủy nếu cần chẩn đoán mô học.

6.2. Bước 2

Kiểm tra máy CO_2, đầu phát, thông số chỉ định, kính bảo vệ phù hợp 10.600 nm và phương tiện bảo vệ vùng lân cận.

6.3. Bước 3

Bố trí hút khói tại nguồn với lọc phù hợp; thực hiện bảo hộ theo đánh giá nguy cơ. Kiểm soát chất dễ cháy và oxy; sát khuẩn phải khô, không đọng dung dịch.

6.4. Bước 4

Gây tê theo y lệnh, tính tổng liều; bác sĩ đánh giá hiệu lực trước can thiệp.

6.5. Bước 5

Bác sĩ phát tia có kiểm soát theo từng tổn thương, đánh giá độ sâu và cầm máu; hút khói đồng thời; dừng khi vượt độ sâu hoặc phản ứng bất thường.

6.6. Bước 6

Đưa máy về chế độ an toàn, kiểm tra vết thương, chăm sóc/băng phù hợp và ghi thông số thực dùng.

6.7. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi chảy máu, bỏng, tổn thương mắt, nhiễm trùng, chậm liền, thay đổi sắc tố, sẹo và tái phát. Đau mắt hoặc giảm thị lực cần khám chuyên khoa khẩn. Không kê kháng sinh thường quy cho mọi vết thương sạch.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

NIOSH. Control of smoke from laser/electric surgical procedures. https://www.cdc.gov/niosh/docs/hazardcontrol/hc11.html

AAD. Skin biopsy wound care. https://www.aad.org/public/diseases/a-z/skin-biopsy-wound-care

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

DL-25. ĐIỀU TRỊ SẨN CỤC BẰNG LASER CO_2

Phiên bản trình thẩm định 1.0 | Đơn vị thực hiện: bộ phận Da liễu theo tổ chức bệnh viện | Ngày hiệu lực: sau phê duyệt

1. ĐẠI CƯƠNG

Bác sĩ phá hủy tổn thương đã chẩn đoán bằng laser CO_2 trong phạm vi kỹ thuật được phép.

2. CHỈ ĐỊNH

Sẩn cục được bác sĩ lựa chọn can thiệp sau đánh giá nguyên nhân và điều trị ngứa.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tổn thương chưa loại trừ ác tính; không có điều kiện kiểm soát khói, cháy hoặc bảo vệ mắt theo thiết bị.

4. THẬN TRỌNG

Đánh giá bệnh nền, đông máu, liền thương và cơ địa sẹo. Không coi mọi máy tạo nhịp là chống chỉ định của laser; nếu phối hợp điện phẫu cần kiểm tra riêng. Không áp dụng phá hủy mọi sẩn cục; nguy cơ sẹo và tái phát cần được giải thích.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực kỹ thuật xác lập chỉ định và thực hiện phần chuyên môn. Điều dưỡng được phân công chuẩn bị, kiểm tra an toàn, hỗ trợ và theo dõi; xác nhận năng lực trước giao việc.

5.2. Thuốc

Kiểm tra y lệnh, dị ứng, nhãn, hạn dùng, nồng độ, liều và đường dùng của thuốc thực tế. Thuốc tê chỉ dùng khi có chỉ định, tính tổng liều toàn buổi. Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ theo quy định; không kê kháng sinh thường quy cho mọi thủ thuật.

5.3. Vật tư

Vật tư phù hợp kỹ thuật, găng và phương tiện bảo hộ theo nguy cơ; vật tư xuyên da vô khuẩn dùng một lần, hộp vật sắc nhọn. Với PRP cần nhãn nhận diện và bộ kit tương thích. Với sinh thiết cần lọ đúng loại xét nghiệm.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra đúng thiết bị/đầu điều trị, tình trạng bảo trì, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện an toàn và thông số được xác nhận. Laser/IPL/LED cần bảo vệ mắt phù hợp; laser CO_2 cần hút khói tại nguồn. Chuẩn bị phương tiện cấp cứu sẵn dùng.

5.5. Người bệnh

Hai định danh; khám vùng, sinh hiệu theo nguy cơ, thuốc và bệnh nền; giải thích lợi ích, giới hạn, tai biến và lựa chọn khác; đồng ý thủ thuật/ghi hình theo quy định. Không tự yêu cầu ngừng chống đông.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, đánh giá nguy cơ, đồng ý, phiếu thông số/thuốc đã xác nhận; thông tin sản phẩm, ảnh có quyền truy cập phù hợp và kế hoạch theo dõi.

5.7. Thời gian thực hiện

Bác sĩ xác định theo diện tích, mức can thiệp, thiết bị và đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc thực tế. Không dùng chung thời gian 30 phút cho mọi kỹ thuật.

5.8. Địa điểm thực hiện

Phòng phù hợp kỹ thuật và phạm vi hoạt động, có vệ sinh bề mặt, xử lý dụng cụ và thông khí phù hợp. Tia UV không thay thế làm sạch/khử khuẩn. Kiểm soát ra vào khi sử dụng laser.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Tạm dừng trước thực hiện: đúng người, kỹ thuật, vị trí/bên, chỉ định và đồng ý; kiểm tra dị ứng, vật tư/thuốc, thông số và khả năng cấp cứu. Nếu chưa đủ điều kiện, dừng và báo bác sĩ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Khám, đánh dấu tổn thương; lấy bệnh phẩm trước phá hủy nếu cần chẩn đoán mô học.

6.2. Bước 2

Kiểm tra máy CO_2, đầu phát, thông số chỉ định, kính bảo vệ phù hợp 10.600 nm và phương tiện bảo vệ vùng lân cận.

6.3. Bước 3

Bố trí hút khói tại nguồn với lọc phù hợp; thực hiện bảo hộ theo đánh giá nguy cơ. Kiểm soát chất dễ cháy và oxy; sát khuẩn phải khô, không đọng dung dịch.

6.4. Bước 4

Gây tê theo y lệnh, tính tổng liều; bác sĩ đánh giá hiệu lực trước can thiệp.

6.5. Bước 5

Bác sĩ phát tia có kiểm soát theo từng tổn thương, đánh giá độ sâu và cầm máu; hút khói đồng thời; dừng khi vượt độ sâu hoặc phản ứng bất thường.

6.6. Bước 6

Đưa máy về chế độ an toàn, kiểm tra vết thương, chăm sóc/băng phù hợp và ghi thông số thực dùng.

6.7. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá tình trạng trước rời phòng; theo dõi đủ theo can thiệp, thuốc tê/an thần nếu sử dụng và nguy cơ thực tế. Bàn giao người bệnh và hướng dẫn bằng văn bản; ghi người thực hiện, thời gian, thuốc/thông số, diễn biến, xử trí và lịch tái khám. Không cho về chỉ dựa một mốc thời gian cố định.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong khi thực hiện

Dừng can thiệp khi có phản ứng bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn, đánh giá ABCDE và gọi hỗ trợ. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline tiêm bắp là xử trí ban đầu theo mức độ phản vệ, không trì hoãn để chờ y lệnh. Nếu nghi ngộ độc thuốc tê với co giật, rối loạn nhịp hoặc suy hô hấp, ngừng thuốc và gọi đội cấp cứu thực hiện phác đồ chuyên biệt.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi chảy máu, bỏng, tổn thương mắt, nhiễm trùng, chậm liền, thay đổi sắc tố, sẹo và tái phát. Đau mắt hoặc giảm thị lực cần khám chuyên khoa khẩn. Không kê kháng sinh thường quy cho mọi vết thương sạch.

7.3. Theo dõi muộn và báo cáo

Tiếp nhận triệu chứng sau thủ thuật, bố trí khám theo mức độ; ghi đáp ứng và xử trí, báo cáo sự cố theo quy định. Bác sĩ đánh giá lại chỉ định trước buổi tiếp theo. Không lặp kỹ thuật khi tai biến hoặc nguyên nhân chưa được giải quyết.

Tài liệu tham khảo và điều kiện đối chiếu

Bộ Y tế. QĐ 4790/QĐ-BYT ngày 25/10/2017, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu. https://benhvienhatrung.vn/wp-content/uploads/2022/07/4790-2017-HD-QTKT-Da-lieu-chi-tiet.pdf

NIOSH. Control of smoke from laser/electric surgical procedures. https://www.cdc.gov/niosh/docs/hazardcontrol/hc11.html

AAD. Skin biopsy wound care. https://www.aad.org/public/diseases/a-z/skin-biopsy-wound-care

Dùng cùng QĐ3023 về đề cương, Thông tư 51/2017/TT-BYT về phản vệ và hướng dẫn sử dụng/nhãn được xác nhận cho đúng sản phẩm, thiết bị của bệnh viện.

PHỤ LỤC 1. PHIẾU XÁC NHẬN TRƯỚC TRIỂN KHAI

Lập một phiếu cho mỗi kỹ thuật/cấu hình hoặc sản phẩm. Không cho thực hiện khi các trường thông số bắt buộc còn trống. Lưu bản IFU/nhãn đối chiếu cùng phiếu; cập nhật khi đổi thuốc, bộ kit, đầu máy hoặc hướng dẫn.

Thông tin cần xác nhận	Nội dung / người kiểm tra
Mã quy trình, danh mục được phép, người đủ năng lực	……
Model, số quản lý, đầu điều trị, IFU và phiên bản	……
Laser/IPL: bước sóng/bộ lọc, fluence, xung, spot, tần số, làm mát, giới hạn và điểm kết thúc	……
Bảo vệ mắt: phổ/bước sóng, mật độ quang học và bảo vệ gần mắt theo IFU	……
LED: bước sóng, cường độ, thời gian/fluence, khoảng cách và bảo vệ mắt	……
Lăn/phi kim: cartridge, độ sâu từng vùng, tốc độ/lực và giới hạn	……
Thuốc tiêm/tê: chế phẩm, đường dùng, nồng độ, tổng thể tích và tổng liều mg, giới hạn cá thể	……
Pha loãng: thể tích gốc, dung môi tương hợp, thể tích sau pha, nồng độ, nhãn và người kiểm tra	……
Sản phẩm phối hợp: bản chất/thành phần, phép lưu hành, đường dùng, vô khuẩn và tương hợp	……
PRP: kit/chống đông, thể tích máu, rotor, RCF/rpm, thời gian, thu phân đoạn, chất hoạt hóa nếu cần	……
PRP: tiêu chí xuất dùng, nhãn, thời hạn/bảo quản, đường sử dụng và truy xuất	……

Thông tin cần xác nhận	Nội dung / người kiểm tra
Sinh thiết: xét nghiệm, loại mẫu, lọ/môi trường và nơi nhận	……
Bác sĩ; dược sĩ khi liên quan; thiết bị; kiểm soát nhiễm khuẩn; phê duyệt	……

PHỤ LỤC 2. BẢNG KIỂM AN TOÀN MỖI LẦN THỰC HIỆN

Nội dung	Đạt / Chưa đạt / Không áp dụng
Đúng người, vị trí/bên, chỉ định, đồng ý	……
Đánh giá thuốc, dị ứng, bệnh nền và nguy cơ	……
Nhân lực và phạm vi kỹ thuật phù hợp	……
Thông số / liều có xác nhận; đúng thuốc và sản phẩm	……
Vật tư vô khuẩn dùng một lần, nhãn và truy xuất	……
Bảo vệ mắt, hút khói/cháy khi liên quan	……
Phương tiện cấp cứu sẵn dùng	……
Ghi thời gian, can thiệp, đáp ứng và tai biến	……
Hướng dẫn sau thủ thuật, bàn giao và lịch theo dõi	……

Người kiểm tra: …… Ngày/giờ: …… Bác sĩ xác nhận đủ điều kiện: ……

PHỤ LỤC 3. NHỮNG ĐIỂM ĐÃ HIỆU CHỈNH

Bổ sung đủ 25 mục, tách bệnh hói khỏi IPL; thống nhất đề cương 7 phần và chuẩn bị 5.1–5.9.

Sửa nm của IPL; không sao chép kính IPL cho LED xanh; không dùng thông số một máy cho mọi thiết bị.

Loại bỏ công thức triamcinolone không nhất quán và trần liều chung; yêu cầu xác nhận đúng chế phẩm và tổng liều.

Loại bỏ công thức hoạt hóa PRP bằng natri clorua chưa được xác minh, quy đổi RCF/rpm mặc định và pha sản phẩm tùy ý.

Bổ sung xác minh đường dùng, tính vô khuẩn và cơ sở sử dụng cho sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc/exosome; không khẳng định hiệu quả chung.

Bổ sung hút khói CO_2, bảo vệ mắt, kiểm soát cháy và chẩn đoán trước phá hủy tổn thương.

Bổ sung phân loại mẫu sinh thiết và theo dõi kết quả; không ngâm mọi mẫu trong formalin.

Thay lịch quan sát/xuất viện, độ sâu kim, số buổi, gây tê và kháng sinh mặc định bằng đánh giá cá thể và tài liệu thực tế.